

Prevence poruch příjmu potravy

Jana Gricová, Hana Papežová

S nárůstem mediálního vlivu na mladou generaci a s rostoucím dopadem nových technologií, hlavně internetu, je úkol vytvořit kvalitní a účinnou prevenci stále nesnadnější. Primární prevence má za úkol snížit riziko vzniku poruch příjmu potravy (PPP). Z posledních výzkumů u nás vyplývá, že prevalence anorexie u nás spíše narůstá.

Zvýšené riziko onemocnění je u dívek, které jsou nespokojené se svou postavou. V důsledku nespokojenosti drží nesmyslné diety, které jsou ale z hlediska komerčního nesmírně výnosné. Je těžké proti těmto komerčním zájmům účinně bojovat. Dívky jsou nespokojené, a to již někdy v šesti letech života, protože nedosahují ideálu krásy, který jim současná společnost vnucuje. Dnes se jedná o virtuální realitu, virtuální ideál, který je normálním, zdravým životním stylem u většiny populace nedosažitelný. Pomocí počítačové techniky jsou krásné modelky ještě dále upravovány, aby na nich nebyla skutečně žádná „chybička“ (vráska, pokrčená látka, stín...). Také narůstá počet soutěží krásy i v dětském věku. Dospělé královny krásy mají často BMI (body mass index) nižší, než je kritérium stanovené odborníky pro diagnózu mentální anorexie (tj. méně než 17,5). Dětské a adolescentní vzory jsou často prezentovány v nedětských, téměř erotizovaných pozicích a oděvech.

V posledních letech se už nedozvídáme o onemocnění PPP pouze ze

životopisů slavných osob, které trpěly anorexií nebo bulimií, jako císařovna Sisi, princezna Diana nebo Jane Fonda a mnoho dalších. Dnes se z médií dozvídáme mnohem dramatictější skutečnosti. Modelky trpící anorexií skutečně téměř přímo na molech na podvýživu umírají. A existují herečky, které trpí závažnou formou anorexie a jejími následky desítky let. Medializovány jsou především tragédie celebrit. Odborníci však mimoto vidí každodenní tragédie celých rodin, které toto „stigma“ skrývají mnohdy i před odborníky, a tím oddalují odbornou péči. Včasná kvalifikovaná intervence ovlivňuje výsledek léčby a lze ji považovat za jeden z faktorů sekundární prevence.

Jednu z akcí boje proti mentální anorexii (AN) zorganizoval slavný italský fotograf Oliviero Toscani. V italském Miláně, považovaném za světové centrum módy, vytvořil provokativní billboardy, pro které mu stála modelem vyhublá herečka Isabelle Carová. Na fotografii váží 31 kg, léta se údajně nenechala fotit, protože se styděla. Tentokrát ale chtěla prospět a pomoci. Toscani chtěl ukázat, kam až může zajít posedlost po dokonale, krásném těle. Ve své kampani řekl, že k rozšíření anorexie velmi přispěl módní průmysl. Kampaň „Ne anorexii“ podpořilo i italské ministerstvo zdravotnictví. Některým se kampaň zdála příliš krutá a nelítostná, vesměs však byla módními návrháři přijata. Některé odborné společnosti poukazují i na možnost negativního





dopadu na dívky postižené AN, které mohou z touhy po publicitě paradoxně svou restrikcí potravy zvýšit. I dobře míněná kampaň může mít negativní důsledky. Podobné tendence skutečně známe z klinické praxe.

Na internetu jsme v posledních letech mohli najít kolem 1 340 000 komentářů k tématu anorexie a módní průmysl. Většina souhlasila s novými pravidly, která Americká akademie pro poruchy příjmu potravy navrhla v roce 2006 módním tvůrcům a doporučila vládám. Měli by podporovat zásady, že modelky mají mít BMI nad 18, do modelingu přijímat dívky až od 16 let (16–18 let), u kterých minimum BMI by mělo být 17,4 pro dívky a 17,7 pro chlapce.

Ale touha po rychlé slávě, úspěchu a penězích už téměř od dětství láká dívky samotné a/nebo jejich rodiče. Svědčí o tom narůstající počet soutěží krásy pro děti a adolescenty (Miss Aerobik, Miss Golf, Miss Mažoretka, Miss Junior, Miss online, Miss Net, Miss Jaro, Miss Reneta). Statistický průzkum ministerstva zdravotnictví Izraele prokázal, že 7 % adolescentních dívek a 13,7 % mladých uchazeček o modeling vykazuje známky AN. Tyto údaje vedly k rozsáhlé kampani proti AN s návrhem zákona zakazujícího modeling dívkám pod BMI 19. Právní a vládní aktivity proti propagaci extrémní štíhlosti jsme zaznamenali ve Velké Británii, ve Španělsku. U nás jsme o takové podpoře zatím jen jednorázově jednali.

Potřeba prevence z hlediska odborníků je velmi komplexní. Za posledních 20 let jsme se setkali s mnoha zkušenostmi s negativními vlivy preventivních opatření především v zahraničí. Známe projekty neúčinné a projekty účinné pouze velmi krátkodobě.

Kvalitní preventivní program s dlouhodobým vlivem na hodnotový systém dětí a adolescentů je v této oblasti vzácný. Na rozdíl od prevence drog a alkoholu, kde většina populace je ochotná připustit škodlivost jejich nadužívání zejména pro dětský organizmus, v oblasti PPP je argumentace daleko obtížnější. Dominující orientace na zevnějšek spojený s úspěšností a zdravým životním stylem a s obavami z obezity dává různým dietám zdánlivě zdravý racionální rámec.

Na internetu můžeme najít kolem 4 650 000 hesel o zdravé výživě. Množství rozporuplných informací představuje nebezpečí především pro děti a adolescenty. Orientace v často extrémních názorech je velmi obtížná. Zvýšená pozornost zdravé výživě a nespokojenost s vlastním zevnějškem mohou být právě rizikovými faktory, které vedou k patologickému jídelnímu chování. Posedlost zdravým životním stylem je komerčně často zneužívána v reklamách, a to především pro děti (naše pacientky se samy pozastavovaly nad reklamou propagující v minulosti sušenku BeBe dobré ráno, která „vám zaručí kalorie na celý den“). Takových zřejmých či skrytých reklam je více, přestože zákon klamavé reklamy zakazuje. Je nutné si uvědomit, že televizní reklamy tvoří až 11 % vysílání a mládež od 10 do 18 let sleduje televizi až 120 minut denně [Uhlíková a Papežová, 2005]. I zde je prostor pro preventivní opatření.

Dodržování zákonů v oblasti PPP by mělo být sledováno podobně jako propagace kouření a alkoholu, opět zvláště pro děti a adolescenty. Odborníci na našem pracovišti na tyto skutečnosti poukazují. snaží se



o spolupráci se zákonodárci a v jednotlivých konkrétních případech nevhodných reklam se snaží o nápravu. K nevhodným reklamám patří i ty, které spojují řešení emočních problémů s manipulací s jídlem (sníte čokoládovou tyčinku a bude vám dobře, i když se hádáte s přítelem, nebo je vám smutno...). Ze záplavy takových reklam v médiích je zřejmé, že boj odborníků je často odsouzen k nezdaru.

Problémem je rozdíl mezi odbornými a mediálními zájmy, cíli a jazykem. Profesionalita zavazuje odborníky, aby svá tvrzení přesvědčivě jednoznačně dokázali, média chtějí za jakoukoliv cenu zaujmout. Sledování rizikových faktorů a specifické problematiky PPP ve výzkumu je dlouhodobé a často nejednoznačné. V záplavě mediálních informací se naopak prosadí pouze velmi emočně vyhodnocené jednoznačné zprávy (dramatické úmrtí modelky, billboardy s extrémně vyhublou modelkou v Miláně). Preventivní poselství těchto výkřiků působí pouze krátkodobě.

V praxi se soustředíme především na práci s rizikovými jedinci, rizikovou populací, rizikové prostředí. Při práci s rizikovými jedinci zásady správné výživy často nestačí, neboť riziková populace je zná daleko lépe než odborníci. Důležité je snížit riziko expozice nevhodným příkladům. Není například vhodné, když učitelka na základní škole chodí každou přestávku zvracet, ostentativně drží diety, z hladovění je z ní cítit acetón, její hmotnost nápadně kolísá, nebo je nezdravě nadměrně zaujata „zdravou“ výživou. Dnes si dospívající všimají i dalších známek problematického vztahu k jídlu. To, co je akceptováno u alkoholu a drog, že závislý

učitel není dobrým příkladem pro studenty, ještě u PPP vždy zřejmé není. Role učitele v prevenci je nezastupitelná. Učitel může být osobou, ke které žáci chovají důvěru, vnímají ho jako člověka, kterému se mohou svěřit se svým problémem a požádat ho o radu nebo pomoc. Může být často první, kdo u žáka odhalí rozvíjející se PPP a nasměruje jeho a jeho rodinu na odbornou léčbu.

Prevence i léčba PPP často přitahují lidi, kteří mají v této oblasti sami problémy. Je pro ně jednodušší radit než změnit vlastní postoje. V zahraničí některá riziková pracoviště mají specializovaný program pro takto trpící jedince a vytvářejí jim podmínky k léčbě (zdravotníci, sportovci, letušky a zaměstnanci leteckých společností, nebo např. psychoedukace a výcvik trenérů, učitelů baletních škol v rámci Americké akademie pro poruchy příjmu potravy). Snižují tím obávanou stigmatizaci z léčby a zároveň se podílejí na motivaci k časnější léčbě zaměstnanců a snižují riziko negativního dopadu onemocnění na pracovišti.

Vede-li preventivní program lektor s evidentní podvábou, může přispět spíše ke zvýšení touhy zhubnout (děti následují, co vidí) než k propagovanému vyváženému stravování (než k tomu, co slyší)! Pravidla nápodoby platí v této oblasti dvojnásob. Nápodoba, zvláště u nejistých jedinců, se týká také celebrit a jejich proklamací ohledně jídelního režimu a diet.

Zejména v období dospívání může být zvýšená sebekritičnost, nejistota sebou samým až nepřijetí sama sebe významným rysem. Častým jevem bývá, že se jedinec hodnotí očima druhých lidí a snadno podléhá sociálnímu tlaku okolí.



V prevenci PPP (ale i u ostatních typů rizikového chování) proto prokázaly svou účinnost takové programy, které zahrnují osobnostní a psychosociální podporu [Tobler a Stratton, 1997] – zaměřují se na podporu zdravého sebevědomí a sebepřijetí, práci se sociálním tlakem, adaptivní „copingové“ strategie, zvládání negativních emocí, podporu kritického myšlení a samostatného rozhodování, ukazují cestu z informačního labyrintu (práce s médii, např. nerealistické fotomontáže modelek, vyvracejí mýty? u extrémních redukčních diet, apelují spíše než na jejich nebezpečnost, na jejich prokázanou neúčinnost? učí, jak prověřovat informace a poznat spolehlivé zdroje, ...).

Jako neúčinné se v preventivních programech jeví pouhé předávání informací o zdravotních rizicích (přesto nelze tato rizika v prevenci podceňovat či onemocnění jakkoliv zlehčovat) bez výše zmiňované osobnostní a psychosociální podpory. Jako dokonce škodlivé u rizikových jedinců může být tzv. předávání negativních „receptů“ – sdělování, co všechno pacienti s anorexií a bulimií dělají, aby si udrželi hmotnost nebo zhubli, vytváří spíše návody těm, kteří se o redukci hmotnosti snaží. Totéž platí o prezentaci šokujících příběhů nemocných.

Nebezpečné mohou být také některé neodborně vedené programy prevence obezity. Mohou situaci ještě zhoršit: vyvěšováním hmotnostních tabulek žáků na nástěnce a kritickými poznámkami k výkyvu hmotnosti v dospívání, veřejným vážením žáků, jak to vidíme někdy ve světě i u nás. Vedou ke stigmatizaci a zvyšují riziko patologického jídelního chování.

Dlouhodobě známe také sportovní programy, kde jsou přímo vyžadovány přísné diety a snížení hmotnosti, některé dívky se právě ve vrcholových sportech naučily regulovat svou váhu zvracením. Do poraden obezitologů přišly i dívky s normálním BMI z baletních škol, aby více zhubly [Housová a Haluzík, 2005].

V preventivních programech je nutné nemluvit o váze, ale o zdraví a zdravém životním stylu! Nestigmatizovat! Je tedy nutné pracovat s přiměřenou tělesnou aktivitou, zdravým sebevědomím, zdravým přístupem k vlastnímu tělu i k jídlu a pití. Programy se mají týkat pouze chování, které lze ovlivnit! Například čas u televize, slazené nápoje, posměch kvůli vzezření.

Předkládané cíle mají být dosažitelné, reálné. Nedosažitelné úkoly mohou mít opačný efekt (např. propagování velmi nízké „ideální“ hmotnosti může vést k přejídání s pocity vlastní neschopnosti, přílišná propagace zdravé výživy vede k tajnému přejídání sladkým). Prevence se podle odborníků ani nemá jmenovat prevence obezity, nemá používat poselství, jako tuky jsou špatné apod., protože vytváří stigmatizaci spojenou s nadváhou a neadekvátní obavy. Je důležité nepodporovat přehnané přemýšlení o jídlu (přílišné přemýšlení o jídlu je právě součástí rizikového chování, nevhodné je, aby se žáci učili počítat kalorie). Žádoucí naopak je podporovat jídelní a fyzickou aktivitu, která je dlouhodobě udržitelná.

Prevenci přizpůsobujeme nejen zralosti populace, se kterou pracujeme, a rizikovému prostředí, ale i znalostem pedagogů či jiných spolupracovníků. Programy mají být supervidované, diskutované a dobře ověřené.



Důležitým médiem pro intervenci je internet. Internet používá 90 % studentů ve věku 12–20 let, více než polovina z nich si na internetu ověřuje své normy, hodnoty, postoje a názory.

Na internetu se objevily i videoklipy majitele modelingové agentury, doporučující mladým dívkám strkat si po každém jídle lžičku do krku a zvracet. Internetová propagace soukromých blogů a stránek vede mladé lidi do soukromé inzerce, která doporučuje, jak dosáhnout „ještě lepší anorexie“. Pro-anorexia implikuje propagaci nebo podporu názoru na AN, v jehož rámci je pojímána spíše jako jedna z forem životního stylu, životní filozofie než jako nemoc [Novák, 2008; Falut, 2008].

PPP jsou v současnosti častěji spojeny se sebepoškozováním. Sebepoškozování i hladovění se může stát skrývaným náboženstvím, pro adolescenta novým společenstvím, způsobem vzdoru, který zůstává okolnímu světu dospělých (rodičů a pedagogů) zcela utajen. Komunikace s rodiči a práce s celou rodinou je často problematická, klasický rodinný život se společnými jídly se stává minulostí. Odborníci dnes vidí v některých rodinách druhou a třetí generaci žen posedlých tělesným zevnějškem a sportovním výkonem se zvýšeným rizikem vzniku formy PPP. V takových rodinách může být PPP dána výchovou i geneticky, je daleko více tolerována a častěji neléčena. Za primární prevenci pro další generaci lze považovat léčbu PPP a prevenci relapsu u generace předchozí, tedy u rizikových rodičů.

Boj s propagací anorektického životního stylu na internetu řeší odborné společnosti na celém světě.

Rušení webových stránek je úspěšné pouze ve velmi alarmujících případech, kde je i laikovi jasné, že je propagováno přímé ohrožení života. V ostatních případech se snaží odborníci doplnit stránky zvyšující riziko PPP i odbornými informacemi o nebezpečí propagovaného jednání.

Vzhledem k rychle se rozvíjejícím technologiím už nestačí písemné stránky, ale je nutné „držet krok“ s novými trendy na poli vývoje technologií. Na internetu probíhá podstatná část komunikace, prostřednictvím různých aplikací se zvyšuje míra interaktivity, a tedy atraktivita trávit v kyberprostoru stále více času. V rizikové populaci, především u dospívajících, se patologické vzorce rychle šíří stejně jako ve školní třídě, jen na sociálních sítích mohou oslovit větší počet lidí. Návštěvníci pro-anorektických stránek se ve svých postojích, hladovění, snaze o nereálnou postavu a negativní vztahu k vlastnímu tělu vzájemně podporují.

Úkolem odborníků je tedy nabídnout v prostředí internetu protiváhu, která by nabízela zdravou a zároveň atraktivní alternativu, aby byl program dospívajícími využíván. V posledním desetiletí odborná pracoviště po celém světě vyvíjejí a evaluuji preventivní internetové programy (např. Univerzita v Heidelbergu, Bauer & Moessner, 2013). Jejich síla spočívá v tom, že dokáží oslovit i mimo školní lavice, v prostředí, které je mladým blízké. Efektivitu prokazují především ty programy, které nabízejí profesionální terapeutickou podporu (například na on-line chatech), možnost diskutovat s dalšími účastníky (supervidované peer forum), mají snadné ovládání a moderní design, využívají možnosti technologií, pracují

s multimédií, hrami a herními prvky, nabízejí interaktivitu a víceúrovňový přístup, kdy návštěvníci využijí podporu podle svých individuálních obtíží. Velmi důležitá je důvěryhodnost a zabezpečení dat. Podstatným důvodem, proč jsou tyto programy využívány, je možnost zůstat v anonymitě, a přesto získat přístup k odborným službám a poradenství. Vzhledem k výraznému utajování problémů spojených s PPP mohou být anonymní internetové programy vhodnou cestou, jak rizikovou skupinu účinně oslovit a podpořit k včasnému vyhledání péče, a tím zvýšit šanci na uzdravení. Účinnost v tomto směru byla prokázána i zahraničními výzkumy [např. Kohl et al., 2013; Paxton, 2013].

Pro kvalitní prevenci je nutné i techniky prevence flexibilně měnit – vhodný jazyk pro komunikaci mezi médií, zákonodárci a odborníky. Užívání nových technologií nám pomůže přiblížit se mladé generaci. Prevence nezahrnuje pouze boj proti riziku zvyšujících se nároků, reklam a mediálních komerčních kampaní, ale také předávání pozitivních hodnot mladé generaci, které ovlivní pozitivnější sebehodnocení a orientaci na životní hodnoty, které nejsou založené na zevnějšku a rychle získaném bohatství. Je možné spojit úsilí v méně specifické prevenci všech negativních jevů u mladé populace. Potřebujeme děti naučit samostatně hodnotit, srovnávat, vybírat, co je podstatné, a pomoci jim vytvořit hodnotový systém, který je bezpečný nebo zdravý. Měly by umět hájit svůj názor a mít možnost vytvářet svou individualitu pomocí vzoru blízkých osob. Základní vzorce chování se tvoří do pěti let života, potřebujeme tedy už

v útlém věku posilovat dětem sebevědomí, dovolit jim rozhodovat se a nést následky svého rozhodnutí, respektovat a podporovat jejich názory, umět pochválit bez výhrad, vytvořit atmosféru důvěry a komunikovat [Šmahel, 2004].

Debra Franko v Praze (2003) uvedla tyto cíle preventivních programů: zlepšení znalostí, sebedůvěry, podněcovat různorodost a chápat změny v pubertě, upravit jídelní návyky, snížit držení diet, snížit posměch, pracovat s médií, „copin-gové“ strategie. Cílem by mělo být i snížení nespokojenosti s vlastním tělem, chápání zdravého jídelního režimu a snížení internalizace ideálu štíhlosti.

V roce 2009 vyšel článek s doporučením pro zdravotnická zařízení, jak pracovat v klinickém prostředí, školách a dalších zařízeních v prevenci proti obezitě a PPP u adolescentů [Krch, 2009]. Doporučení jsou založena na závěrech projektu EAT, který zkoumal jídelní zvyklosti adolescentů:

- Snažte se zabránit nezdravým dietám, a naopak podporujte jídelní a fyzickou aktivitu, která může být dlouhodobá.
- Pracujte na pozitivním vnímání vlastního těla.
- Podporujte častější a příjemné společné rodinné stolování.
- Podporujte rodiny, aby méně mluvily o váze a snažily se, aby se doma jedlo a cvičilo zdravě.
- Předpokládejte, že dospívající s nadváhou zažívají šikanu, a mluvte o tomto problému s vrstevníky a jejich rodinami.

Doporučení zdůrazňuje nutnost pomoci adolescentům a jejich rodinám méně se zabývat váhou a více postupnými



změnami chování. V útlém dětství prevence spočívá v edukaci matek o významu správné výživy dětí.

Pro kvalitní prevenci je důležitá mezioborová spolupráce, o kterou se snažíme na odborných konferencích (např. konference o primární péči, o PPP). Na konferenci o PPP zveme nejen psychiatry, psychology, ale i učitele, PPP, zdravotní sestry a rehabilitační pracovníky, i média, a v minulosti organizátory soutěží krásy. Spolupracujeme i v rámci Evropy. V evropské spolupráci byly navrhovány:

- Evropský atlas služeb pro PPP;
- standardní soubor preventivních programů pro mladé a pro rodiny;
- standardní preventivní programy pro profesionály;
- rozvoj evropské informační sítě a společných webových stránek pro PPP.

V oblasti primární prevence realizované ve školních třídách můžeme optimisticky předpokládat, že úroveň preventivních programů bude stoupat a do určité míry se zamezí neodborně vedeným preventivním programům díky vytvoření a zavedení do praxe standardů odborné způsobilosti pro realizátory programů školské primární prevence rizikového chování [Pavlas, Martanová, 2012]. Standardy vycházejí z výzkumem a praxí ověřených principů účinné prevence. V současné době mají tedy školy možnost vybrat si mezi certifikovanými organizacemi, aktuální seznam lze nalézt na stránkách MŠMT. V každé škole má na starosti preventivní aktivity školní metodik prevence, který by měl absolvovat 250hodinové specializační studium, školy mohou také využít

podpory od metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně.

Realizované preventivní programy u nás

První internetová adresa vedená odborníky – www.idealni.cz – vznikla s podporou Asociace pro pacienty s PPP a postupně rozšiřuje informace o mapování služeb, informace o onemocnění, moderní literaturu pro rizikovou populaci.

K časné intervenci a sekundární prevenci PPP v rodinách byla zavedena vícerodinná terapie (multifamily treatment). Vícerodinný přístup v různých trvajících cyklech spočívá v setkání několika rodin během několikadenních nebo jednodenních setkání s komplexními psychoterapeutickými a psychoedukačními aktivitami vedenými odborníky.

S podporou mezinárodního výzkumu INTACT vznikl internetový chat pro rodiče postižených, kteří mají často klíčovou roli, ale obtížný přístup k jiným formám informací a podpory – www.pomocppp.cz. Cílem bylo zabránit rozvoji závažnější, klinické formy onemocnění v začátcích dietního chování. Projekt *Propojení* umožnil v týdenních intervalech rodinným příslušníkům chatovat se specializovanými odborníky i ostatními uživateli se stejnými potížemi.

Bezbariérové klubové aktivity pro ohrožené, kde získají informace od vrstevníků, pacientů s různými formami onemocnění, možnostmi léčby i podporou resocializace.

Telefonické poradny vedené terapeuty i školeným personálem k zodpovězení široké škály otázek o časných intervencích, stále častěji se postižení obrací na Linky důvěry.



Specialisté z Centra pro PPP vytvářejí on-line materiály [např. Papežová, 2000; Papežová, Hanusová, 2012] a poskytují supervizi pro specializované programy ve školách nebo programy, které se zabývají riziky dalších nebezpečných aktivit, jako je sebezpoškozování a současný abúzus návykových látek.

V letech 2011–2015 se naše centrum účastnilo mezinárodního projektu ProYouth (European Initiative for Eating Disorder Prevention), vyvinula ho Univerzita v Heidelbergu a podílelo se na něm sedm evropských zemí. ProYouth spojoval získané předchozí poznatky o implementaci programů a současné požadavky na preventivní program: nabízel informace pro metodiky a učitele, odkazy na webové stránky, počítačovou hru a internetové intervence podle různých potřeb mládeže v riziku onemocnění.

Současné preventivní programy

Na ProYouth jsme navázali a rozšířili ho naším dalším projektem **Healthy and Free** (www.healthyandfree.cz, www.pomocppp.cz). E-clinic, z.ú., Centrum sociálních služeb Praha a norská nezisková organizace ROS společně získali v rámci Norských fondů 2015/2017 grant na vývoj tohoto programu.

Healthy and Free, stejně jako ProYouth cílí na dospívající od 15 let a dospělě v riziku, kteří mají mírné až středně závažné obtíže (mají obavy z přibírání, jsou nespokojeni se sebou a svou postavou, experimentují s dietami atd.) a také na ty, kteří PPP trpí, jejich rodiče, blízké, učitele.

Zipyho a Jablíkovi kamarádi

Jednou z mála metodik dostupných pro děti předškolního a mladšího školního věku jsou *Zipyho kamarádi* a na ně navazující *Jablíkovi kamarádi*. Jedná o se praxí ověřený a mnohokrát evaluovaný soubor aktivit, které s dětmi provádí proškolený učitel. Práce s metodikami rozvíjí u dětí jejich schopnosti vyrovnat se se stresovými událostmi (tzv. coping strategies) a sociální dovednosti. Rozvíjí se schopnost dětí vyjádřit vlastní emoce, řešit konflikty, navazovat a udržet si přátelské vztahy, umět si říci o pomoc v případě potřeby a další, což vede k vytváření protektivních faktorů ke snížení negativních jevů v dětství i adolescenci, včetně PPP. Metodiky vyvinula britská organizace Partnership for Children a rozšířila je do více než 30 zemí světa. V České republice jsou *Zipyho kamarádi* k dispozici od roku 2015 díky projektu E-clinic, z.ú., a Centra sociálních služeb Praha podpořeného z Norských fondů. Pokračování projektu a jeho rozšíření o metodiku *Jablíkovi kamarádi* je podpořené grantovým programem *Praha – pól růstu*. Informací o metodikách a evaluační zprávu (kontrolovaná randomizovaná pre-post test studie) lze najít na www.zipyhokamaradi.cz.

První světový den o poruchách příjmu potravy (The World Eating Disorder Day of Action) dne 2. 6. 2016 vznikl díky spolupráci odborníků z celého světa, kteří se shodli na společně šířených vědecky podložených informacích o PPP.

Odborníci celého světa se shodli na devíti pravdách o PPP, které mohou ulehčit vyhledání pomoci postiženým a poskytnutí pomoci odborníkům



a rodinným příslušníkům. Naši odborníci přidali pravdu desátou.

Pravda 1: Mnoho lidí s poruchou příjmu potravy může vypadat dobře i přes extrémně vážně onemocnění.

Pravda 2: Rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nejlepším spojencem pacientek i zdravotníků.

Pravda 3: Diagnóza poruchy příjmu potravy je zdravotní krizí, která poškozuje osobní i rodinné vztahy a fungování.

Pravda 4: Poruchy příjmu potravy nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou biologicky ovlivněnou nemoc.

Pravda 5: Poruchy příjmu potravy postihují v současnosti lidi všech věků, etnicit, tělesných tvarů a váhy, sexuálních orientací a socioekonomických úrovní.

Pravda 6: U poruch příjmu potravy narůstá riziko sebevražd i zdravotní komplikace.

Pravda 7: Geny a prostředí hrají důležité role v rozvoji poruch příjmu potravy.

Pravda 8: Geny samotné však neodhalí, kdo poruchou příjmu potravy onemocní.

Pravda 9: Úplné uzdravení je možné, včasné rozpoznání a intervence jsou velmi důležité.

Pravda 10: Nespokojenost s vlastním tělem souvisí často s nespokojeností se sebou samým, nízkým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního těla spojeným s prožívaným stresem a rizikem pro vznik poruchy příjmu potravy.

Souhrn pro klinickou praxi

Prevence je nezbytná součástí odborné péče. Vyžaduje spojení výzkumu rizik a preventivních programů jednotli-

vých oborů, aby omezené prostředky byly efektivně využity. Nemůžeme se spokojit s pouhým posuzováním poznatků cílové populace. Většina programů dokáže zvýšit znalosti a povědomí o onemocnění, ale to není dostatečné. Potřebujeme změnit postoje k PPP, a to dokáží pouze některé programy. Velmi málo programů skutečně vede ke změnám jídelního chování, a to by měl být do budoucnosti náš skutečný společný cíl.

Propagace anorexie (pro-ana stránky) i prevence a psychoedukace (podobně jako společenské kontakty a další aktivity) jsou u adolescentů stále více přesouvány na internet. Preventivní opatření se musí přizpůsobit těmto trendům. Je nezbytné nepřestat hledat nové individualizované přístupy, nové poznatky a přístupy ke zlepšení průběhu onemocnění u pacientů i jejich rodin i přátel a spolupracovat na odborném šíření poznatků a mezioborové spolupráci na změně postojů odborníků i celé populace.

Literatura u autorů

Podpořeno Progres Q27,
AZV 17-28905A.

*Mgr. Jana Gricová
Centrum sociálních služeb Praha
Pražské centrum primární prevence
1. lékařské fakulty UK
E-clinic, z.ú.*

Text byl přetištěn se souhlasem nakladatelství Mladá fronta z publikace *Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání* prof. MUDr. Hany Papežové, CSc. a spolupracovníků, kterou nakladatelství Mf vydalo v roce 2018.